جرّبت مستشفيات سترة «لا تقاطعني» لتحمي الممرضين في أثناء إعطاء الأدوية.

لكن تجربة عشوائية لم تجد أنها خفّضت الأخطاء.

هذا ما تقوله خمس دراسات نُشرت بين عامي 2021 و2025.

← اسحب للمتابعة

ماذا يحدث في أثناء جولة الأدوية؟

يُقاطَع الممرضون مرات كثيرة: زميل يسأل، أو طبيب يطلب شيئًا، أو مستلزم مفقود يجب البحث عنه.

وفي مراجعة جمعت نتائج 22 دراسة، وجدت 16 دراسة منها ارتباطًا يُعتدّ به بين المقاطعة وزيادة أخطاء إعطاء الدواء.

اختلفت الدراسات في تعريف المقاطعة والخطأ، والارتباط لا يثبت وحده أن المقاطعة هي السبب.

من أين تأتي المقاطعة؟

من الزملاء، ونقص المستلزمات، والهاتف

182

مقاطعة رصدها باحثون في 15 جولة أدوية بمستشفى سعودي، وكان الممرضون والأطباء والعوائق أكثر مصادرها.

+20

مقاطعة في الساعة يصل إليها الصيادلة في بعض الدراسات، أكثرها من الهاتف وأسئلة المرضى.

ولا يقتصر الأمر على التمريض.

التجربة

سترة «لا تقاطعني» في أربعة مستشفيات فرنسية

لبس الممرضون السترة في جولات الأدوية، ووُضعت لافتة عند مدخل الوحدة تشرح الأمر للمرضى وذويهم.

ووُزّعت 29 وحدة بالقرعة: 14 وحدة طبّقت السترة، و15 وحدة بقيت على العمل المعتاد. وراقب مراقبون مدرَّبون 383 جولة أدوية.

النتائج

لم تقلّ الأخطاء، ولم تؤثر السترة في المقاطعة

7.09%

من الجرعات وقع فيها خطأ في الوحدات التي طُبّقت فيها السترة، مقابل 6.23% في الوحدات الأخرى.

15.04%

من الجرعات قُطع العمل فيها، بعد أن كانت 13.4% قبل التجربة. وفي الوحدات الأخرى انخفضت من 23.78% إلى 20.75%.

وخلص الباحثون إلى أن السترة لم تؤثر في الأخطاء ولا في معدل المقاطعة.

لماذا لم تنجح السترة؟

بقيت مقاطعة الزملاء شائعة

ففي مراجعة لـ 14 دراسة، بقيت مقاطعة الممرضين بعضهم بعضًا شائعة حتى مع السترات والحملات، وبقي أثر هذه الحلول في الأخطاء غير محسوم.

فالسترة تخاطب مصدرًا واحدًا، وكثير من المقاطعات عرَض لنظام لا يوفّر المستلزم أو المعلومة في وقتها.

الجملة الأخيرة تفسير من الكاتب استنادًا إلى هذه الدراسات، لا نتيجة قاستها.

مستخلص من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

يبدأ بالقياس، فيسأل: من يقاطع؟ ومتى؟ ولماذا؟

2

ويزيل أسباب المقاطعة من مصدرها، فيضع المستلزمات في مكانها، ويحوّل الأسئلة إلى زميل لا يعطي الدواء.

3

ويقيس الأخطاء نفسها، لا عدد من لبسوا السترة.

> أيّ عمل دقيق في مؤسستك يُقاطَع أكثر من غيره، ومن أين تأتي مقاطعاته؟

حدود هذه الأدلة

جُمعت بيانات التجربة الفرنسية عام 2017، واختبرت السترة واللافتة فقط.

اختلفت تعريفات الدراسات في المراجعات، فلم تُجمع نتائجها في تحليل واحد.

من بين الدراسات الخمس دراسة واحدة فقط في مستشفى عربي، وتعميمها على قطاعات أخرى استنتاج.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Schroers, G., et al. (2025). Associations between interruptions and medication administration errors among nurses in hospital settings. *J Adv Nurs*, 82, 2551–2569.

[2] Eid, T., et al. (2022). Interruptions during medication work in a Saudi Arabian hospital. *J Nurs Scholarsh*, 54(5), 639–647.

[3] Ayanaw, M., et al. (2025). How do interruptions and distractions affect pharmacy practice? *Res Social Adm Pharm*, 21(9), 667–678.

[4] Berdot, S., et al. (2021). Effectiveness of a ‘do not interrupt’ vest intervention to reduce medication errors. *BMC Nursing*, 20, 153.

[5] Zhang, W., et al. (2025). Effectiveness of interventions for reducing interruptions during medication administration. *Worldviews Evid Based Nurs*, 22(4), e70067.